

VEZETŐI BRIEF INTÉZMÉNYEKNEK

A viselkedés, ami nem agresszió

*7 helyzet, amit másképp is meg lehet
oldani — vezetői brief*

KÉSZÍTETTE

Stoiber Vivien

Demenciaszakértő · gyógytornász

DEMENCIAROLERTHETOEN.HU

A viselkedés, ami nem agresszió

7 helyzet, amit másképp is meg lehet oldani — vezetői brief

Egy gyakorlati segédlet igazgatóknak, főnövéreknek és csapatvezetőknek arról, hogy mit mond a viselkedés — és mit lehet tenni, mielőtt gyógyszert kérnél.

Stoiber Vivien — A demenciáról érthetően

Mielőtt belevágsz

Kedves Olvasó,

ha ezt a brifet megnyitottad, valószínűleg ismerős a hétfő reggeli mondat: „A 14-essel megint nem boldogultunk. A család panaszkodott. A csapat kimerült. Az orvos megemelte az adagot.”

Ez a jelenet ma nem ritka. És fontos: ez nem azt jelenti, hogy a csapatod rosszul dolgozik. Azt jelenti, hogy a csapatodnak nincs még közös szemlélete arra, mit jelent a viselkedés.

A demencia esetében szinte mindig van ok a viselkedés mögött. Fájdalom, félelem, unalom, túl sok inger, fáradtság, szégyen, vagy hogy a lakó nem érti, mi történik vele. Ha a csapat ezeket az okokat fel tudja ismerni, sokkal kevesebb erős nyugtatóra lesz szüksége.

A következő hét oldalon hét visszatérő helyzetet veszünk végig. Mindegyiknél négy dolgot nézünk meg:

- **Amit a csapat lát.**
- **Mi van mögötte.**
- **Amit eddig csináltak — és miért nem működik.**
- **Amit helyette tehettek — és mit érdemes közben mérni.**

Olvasd el. Vidd be a következő vezetői megbeszélésre. A csapattal együtt nézzétek át.

Vivien

A három alapelv

Mielőtt a hét helyzetnél elindulnánk, három mondatot érdemes elől tartani. Ezek mindegyik helyzetben működnek.

1. A viselkedés mindig kommunikáció

A demencia előrehaladtával az agy egyes részei már nem ugyanúgy működnek. A lakó nem tudja szavakkal megfogalmazni, hogy fáj a háta, hogy fél, vagy hogy szomjas. Ezért a teste mondja el. Ordítással, indulattal, mozdulatlansággal, vagy azzal, hogy elindul kifelé.

Ha a viselkedés mögött nem látunk okot, az nem azt jelenti, hogy nincs ok. Csak még nem találtuk meg.

2. A környezet sokszor a fő ok

A lakók viselkedése jelentős részben a környezetre reagál. Zajra, fényre, hidegre, idegen emberre, túl sok ingerre, vagy egy ismeretlen szobára. Ha mindennap ugyanaz a fény és ugyanaz a hang, a csapat azt fogja érezni, hogy a lakó megváltozott. Pedig csak a környezet maradt változatlan.

A viselkedés mérése ezért mindig a környezetet is méri. Nem csak a lakót.

3. A gyógyszer az utolsó válasz, nem az első

Az erős nyugtató gyógyszereket csak akkor érdemes adni, ha minden más megoldást rendszeresen kipróbáltatok, és a lakó vagy mások biztonsága valóban veszélyben van. Az ilyen gyógyszereket az adagolásban időben korlátozni kell, és rendszeresen felül kell vizsgálni.

Ha a csapatnál hetente egynél több új nyugtató indul, ott nem a gyógyszer a megoldás — hanem a szemlélet, ami felé most tartunk.

I. Agresszió fürdetésnél vagy öltöztetésnél

Amit a csapat lát. A nővér bemegy fürdetni. A lakó ordít, eltol, ütésre emeli a kezét. Két nővér próbálja megfogni. A jelenet eszkalálódik.

Mi van mögötte. A fürdetés a lakó számára egyike a legintimebb és legfenyegetőbb helyzeteknek. Az ismeretlen érintés a veszély jelét adja az agyában. Ha nem érti, miért kell levetkőznie, az nem szégyen — *félelem*. Ez nem agresszió. Ez védekezés.

Amit eddig csináltak. Két nővér tartja, harmadik fürdet — vagy nyugtató kerül elő. Ez rövid távon megoldja az adott alkalmat, de a következő héten ugyanígy fog történni.

Amit helyette tehettek. Először kapcsolódás: név, mosoly, lassú érintés a vállnál. Utána bejelentés egyszerű mondattal: „most a vizet megnyitom.” Utána választás: melyik törölközőt kéred? A meleg víz, a meleg szoba, az ismerős illat — ezek mind csökkentik a feszültséget. A kéz vezetése (kéz alá tett kéz) biztonságos érintéssé válik.

Amit érdemes mérni. Hány fürdetés végződik fizikai korlátozással vagy emelt hangú jelenettel? Ezt heti összesítésben kérdezzétek le a műszakok végén. Egyetlen szám, ami megmutatja, merre haladtok.

2. Esti nyugtalanság

Amit a csapat lát. Délután 4 óra van. A lakó addig nyugodt volt. Most felkel, indul az ajtó felé, hangosabban beszél, indulatos lesz. A nővér leültetné, ő emelt hangon válaszol.

Mi van mögötte. Ez egy ismert jelenség: ahogy közeledik az este, a belső óra zavarodik, a fáradtság gyűlik, a fény változik. A lakó testében ott él egy régi rutin: most kéne hazamenni a munkából, most kell vacsorát főzni. Ettől nem érzi magát biztonságban a jelenlegi helyén.

Amit eddig csináltak. Nyugtatót adunk, vagy ismételjük: „üljön le, itt él.” Egyik sem segít — a lakó még kevésbé érzi magát biztonságban.

Amit helyette tehettek. Az esti nyugtalanság nem a pillanatban dől el — délután 2 körül. Egy rövid séta, egy fény melletti 20 perc, egy kis szénhidráatos snack, csendes pihenés — ezek mérhetően csökkentik a 16:00–18:00 közötti csúcsot. A pillanatban: ismerős hang, egy fél kávé, egy „meséld el, milyen volt otthon” kérdés. A cél nem az, hogy a lakó megnyugodjon — hanem hogy újra biztonságban érezze magát.

Amit érdemes mérni. Hány ilyen helyzet végződik gyógyszerrel, és hány úgy, hogy a nővér ráhangolódott? A két szám aránya megmutatja, mennyire mozdul a csapat.

3. Ugyanazt kérdezi sokadszor

Amit a csapat lát. A lakó tizenötödször kérdezi meg, hány óra van. A nővér eleinte türelmes, aztán éles lesz. A lakó érzi a hangsúlyt, és gyakrabban kérdez.

Mi van mögötte. Az agy adott területe már nem tudja megtartani az új információt. A lakó nem felejt — be sem tudja venni. Minden kérdés az első neki. A repetíció mögött sokszor nem a kérdés van, hanem egy érzés: szorongás, kontroll-igény, valami történni fog, és nem tudom, mi.

Amit eddig csináltak. „Most mondtam, anya.” → szégyen → még több kérdés.

Amit helyette tehettek. Először rövid, nyugodt válasz, ítékezés nélkül. Utána átvezetés egy közös tevékenységbe: séta, tea, képnézegetés. Ha a kérdés mögötti érzés azonosítható (például mintha várnánk valakit), arra is válaszoljunk: „nem várunk senkit, együtt vagyunk.”

Amit érdemes mérni. Volt-e a héten olyan műszak, amikor a csapat a lakó kérdezgetését kezelhetetlennek címkézte? Ezt érdemes nyilvántartani — nem a lakó miatt, hanem mert ez a csapat fáradtságának korai jelzése.

4. Visszautasítja az ételt

Amit a csapat lát. A lakó eltolja a tányért. „Nem éhes.” Kétszer-háromszor próbálkozik a nővér, aztán feladja. A táplálkozási állapot romlik.

Mi van mögötte. Az étel visszautasítása szinte sosem szándékos. Leggyakoribb okok:

- Az étel nem felismerhető — az agy nem érti, hogy ez étel.
- Túl sok inger az étkezőben (zaj, fény, mozgás).
- Fájdalom, gyakran a szájüregben vagy a nyelésnél.
- Fáradtság — a rágás komoly munka.

Amit eddig csináltak. Sürgetés, „egyél, anya, egészséges”, vagy szondás táplálás.
→ következő étkezésnél még nagyobb ellenállás.

Amit helyette tehettek. Az étkezés legyen élmény, ne feladat. Csendesebb környezet. Ismerős evőeszköz, ismerős étel (a fiatalkori kedvencek sokszor működnek). Kontrasztos színű tányér (a fehér krumpoli fehér tányéron láthatatlan). Időkorlát eltörlése: 45 perc, ha kell. Ujjal ehető falatok visszaadhatják az étkezés örömet.

Amit érdemes mérni. Az étkezéseknél elfogyasztott mennyiség heti átlaga lakónként.
És: hány étkezés végződik úgy, hogy a lakó feláll és elmegy?

5. „Haza akarok menni”

Amit a csapat lát. A lakó nyugtalan, az ajtó felé indul, ordít: „Haza akarok menni.” A nővér próbálja meggyőzni, hogy itthon van, itt él. A lakó hangja erősebb lesz.

Mi van mögötte. A „haza” nem földrajzi hely. A „haza” az a biztonság, amit valamikor érzett. Ismerős környezet, kontroll a saját élete felett. Ezt most elveszítette. Sokszor az otthon, amire emlékszik, már nem is létezik — gyerekkori lakás, házasság előtti otthon.

Amit eddig csináltak. Korrekt: „itthon van, itt él.” Vagy nyugtató. Vagy ajtózáras. → eskaláció.

Amit helyette tehettek. A „haza” érzését újrateremtjük itt. Egy ismerős hang, egy ismerős tárgy a táskájából, fél kávé, egy „meséld el, milyen volt otthon” kérdés. A cél nem az, hogy elfogadja, hogy itt van. A cél, hogy itt is otthon legyen pár percig.

Amit érdemes mérni. Hány „haza akar menni”-eset végződik gyógyszerrel, és hány úgy, hogy a nővér ráhangolódott? Ez a szám megmutatja, hova tartotok.

6. „Elloptátok!”

Amit a csapat lát. „Elloptátok a gyűrűmet!” A nővér tudja, hogy a gyűrű az éjjeli szekrényben van. Megmutatja. A lakó tagadja, hogy az övé lenne. A vád megismétlődik másnap is.

Mi van mögötte. Két dolog történik egyszerre. Az egyik: az emlékezet hiányát az agy kitölti — a lakó nem hazudik, csak a hézag meséli el helyette. A másik: elveszett a kontroll. A lakó már nem tudja, hol vannak a tárgyai, és ez rettenetes érzés. A vádaskodás nem a nővér ellen szól. A zavaros világ ellen szól.

Amit eddig csináltak. Védekezés, bizonyítás („nem vettem el, ott van”), vagy a család bevonása. → szégyen → még több gyanú.

Amit helyette tehettek. Ne védekezzünk. Csatlakozzunk: „Hadd nézzem meg veled, hol lehet.” Közös keressük. Amikor megvan, nem mondjuk meg, hogy ott volt mindig. „Nézd, itt van. Tedd vissza biztonságos helyre.” A keresés maga adja vissza a kontrollt.

Amit érdemes mérni. Volt-e a héten olyan eset, amikor a családhoz fordultatok vádaskodás miatt? Ha igen, érdemes átnézni a kommunikációt — ez majdnem mindig elkerülhető.

7. WC-nehézségek

Amit a csapat lát. A lakó nem talál vissza a WC-be. Néha a sarokba ürít. A nővér frusztrált. A higiénés feladat eszkalálódik. Pelenka kerül szóba.

Mi van mögötte. Ez szinte sosem az önkontroll elvesztése. Sokkal gyakrabban:

- Nem találja a WC-t. A WC ajtaja nem feltűnő, a folyosó túl hosszú, az éjszakai lámpa hiányzik.
- Késő szól. Érti az ingert, de mire szólna, már későn van.
- Fájdalom. Húgyúti fertőzés demenciában gyakran zavartság formájában jelentkezik először.
- Idegen, kelletlen környezet. A WC hideg, idegen, túl messze van.

Amit eddig csináltak. Pelenka, korlátozás, frusztráció. → a lakó méltóságérzete csökken, a viselkedés romlik.

Amit helyette tehettek. Először orvosi okok kizárása — húgyúti fertőzés gyanúja esetén szűrjétek. Utána: kontrasztos WC-ajtó, éjszakai lámpa, irányjelző. Rendszerített ürítési időpontok kétóránként, ajánlatként, nem kérdésként („most menjünk?”, nem „kell-e?”). A pelenka legyen utolsó lépés, ne első.

Amit érdemes mérni. Hány új lakónál került pelenka bevezetésre az első hónap során, és hány esetben végeztetek előtte fertőzés-szűrést és környezet-auditot? Ennek a két számnak az aránya közvetlenül mutatja az ellátás minőségét.

A négy szám, amit havonta nézz

Egy demens-osztály változását négy szám mutatja meg — vezetői szempontból ez a négy a legfontosabb. Ha ezeket havonta nézed, két hónapon belül látni fogod, mozdul-e a csapat.

1. Hány új nyugtató indul / 100 lakó-nap?

Az egyetlen szám, amit nemzetközi standardok elsőként ajánlanak mérni. Európai emberközpontú intézményeknél tipikusan havonta 1–2 új felírás / 100 lakó-nap. Magyarországi átlag ennek többszöröse. Ennek a számnak csökkennie kell.

2. Hány „nehéz” műszak volt a héten?

Hetente egyszer kérdezzétek le a műszakok végén, 1–5 skálán: „Mennyire volt nehéz ez a műszak?” A 4–5-ös értékek aránya a csapat-kiégés legkorábbi jelzője. Ennek a számnak csökkennie kell.

3. Hány hozzátartozói panasz érkezik havonta?

A hozzátartozói panaszok szinte mindig a csapat-kommunikáció minőségét tükrözik, nem a klinikai eseményekét. Ennek a számnak csökkennie kell.

4. Mennyi a csapat fluktuációja egy év alatt?

Az emberközpontú munka megtartja a csapatot. A folyamatos „kezelhetetlen” lakók fárasztják el az embereket. Ennek a számnak csökkennie kell.

Ha mind a négy mozdul jó irányba két hónapon belül — az a változás. Ha akár egy is rossz irányba mozdul — érdemes újratervezni.

Mi következik

Ez a brief egy keretet adott. A keret önmagában nem elég — a csapatnak gyakorolnia kell. Két irány nyitva van innen:

Ha a csapatom a szakmai elmélyülésre készen áll. A Demencia-kommunikáció kompetens kódexe a peer-szakmai mélységű referencia. 20 oldal, magyar adaptáció, terminológiai vita-javaslat. Ingyen letölthető a demenciarolerthetoen.hu/letoltesek oldalon.

Ha az intézményeknek célzott támogatás kell. Szívesen tartunk csapatreflexiót, célzott workshopot vagy hosszabb szakmai tanácsadást. A keret közös, a téma a tiétek: a saját 14-es szobátok, a saját hétfő reggeli megbeszélésetek. Egyetlen email a info@demenciatanacs.hu címre — 1–2 napon belül visszajelzek a részletekkel.

És még valami. Ez a brief azzal indult, hogy a nyugtató-igény heteken belül jelentősen csökkenthető. Ez nem propaganda. Nemzetközi adat, magyar tapasztalat. De csak akkor működik, ha a változást a vezetők akarják először. A csapat ezt érzi — a változási kísérletek 80%-a azon múlik, hogy a vezető elhiszi-e.

Ha eddig elolvastad, akkor te elhiszed.

Mert együtt könnyebb.

Vivien